HELP_Organi_P21 — Groupe E — Lots 242 à 246 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 21 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

E-016 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 › fenêtre « donneur potentiel »

Contexte : Le cours renvoie aux catégories SwissPOD (donneur possible, potentiel, éligible, effectif, utilisé) sans leur définition exacte.

Question : Quelles définitions exactes des catégories de donneurs (possible, potentiel, éligible, effectif, utilisé) utilise l'étude SwissPOD ou le monitoring Swisstransplant/CNDO, et correspondent-elles au « critical pathway » de l'OMS/Madrid 2011 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-021 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › fenêtre « biopsie du greffon rénal interprétée selon Banff » et tableau DSA

Contexte : Le cours dit que la biopsie seule distingue rejet, toxicité du tacrolimus, néphropathie BK et récidive ; seuils de positivité des DSA (MFI) et modalités de monitorage absents.

Question : Quels critères de Banff (classification la plus récente, Banff 2022) définissent le rejet cellulaire et humoral, quels seuils de MFI des DSA et quel calendrier de dépistage des DSA de novo recommandent les centres suisses (STCS, SwissTransplant) ou le consensus STAR 2022 ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-022 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 › fenêtre « don vivant » (conditions légales) et fenêtre « ABO-incompatible »

Contexte : Le cours cite LTx art. 12 et la greffe ABO-incompatible pratiquée en Suisse depuis 2003 ; préparation du receveur absente ; note que l'imlifidase ne la prépare pas.

Question : Quelle préparation du receveur d'une greffe rénale ABO-incompatible appliquent les centres suisses (rituximab : dose et délai, immunoadsorption ou plasmaphérèse, titre cible d'isoagglutinines) et quelle est la recommandation européenne la plus récente (ERA/EAU, EDQM « Guide to the quality and safety of organs ») ? Quelles conditions légales du don vivant fixe la LTx art. 12 (état en vigueur) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-024 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 › tableau des alternatives (stimulateur incompatible avec l'IRM) et tableau des traitements du donneur vivant (② autres antalgiques, ④ antihypertenseur)

Contexte : Le cours cite Dafalgan® i.v. (FI orale non lue), aucun autre antalgique, un antihypertenseur sans classe ni dose (cible 130/80 mmHg) et l'angio-TC si stimulateur incompatible avec l'IRM.

Question : Quelle antalgie postopératoire après néphrectomie de don (paliers, AINS à éviter ou non, opioïdes) et quel traitement antihypertenseur au long cours du donneur vivant (classe de premier choix, cible) recommandent le SOL-DHR, les centres suisses ou les recommandations européennes (ERBP, ESH 2023) ? Quelle imagerie vasculaire rénale choisir chez le candidat porteur d'un stimulateur incompatible avec l'IRM ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-025 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 et DX.7 › tableaux des alternatives (allergie au contraste iodé, stimulateur incompatible avec l'IRM)

Contexte : Le cours privilégie l'échographie Doppler ; recommandation suisse pour l'imagerie avec contraste chez le greffé et produit de substitution absents.

Question : Quelle conduite recommandent la Société suisse de radiologie (SSR), ESUR (Contrast Media Guidelines, version la plus récente) ou les centres suisses chez le greffé rénal ou hépatique allergique aux produits de contraste iodés (prémédication, produit alternatif, échographie de contraste) et chez le porteur d'un stimulateur incompatible avec l'IRM ? Préciser le risque néphrotoxique chez le greffé rénal. Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-029 — Moyenne — LOT 242 · SSP O7.20

Emplacement : LOT_242_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.10 › fenêtres « obligation de déclarer (OTx art. 15) », 3.3 « déclaration à l'OFSP et secret médical », « moyens institutionnels », « organes importés légalement » et piège des 18 cas déclarés

Contexte : Le cours cite l'OTx art. 15 (déclaration dans l'année du début du suivi) et 18 cas déclarés ; Code FMH, avis juridique sur la dénonciation et chiffres européens du tourisme de transplantation absents.

Question : Que prévoient le droit suisse (LTx art. 69–70, OTx art. 15, CP 321) et le Code de déontologie FMH sur la déclaration d'une greffe effectuée à l'étranger et la dénonciation d'un trafic d'organes présumé ? Combien de déclarations l'OFSP a-t-il reçues depuis 2017 (dernier chiffre) et quelles données européennes récentes (Conseil de l'Europe, Convention contre le trafic d'organes humains, ratification suisse) existent ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-034 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › tableaux des examens (taux de ciclosporine/tacrolimus, INR, digoxinémie) ; Partie 1 › DX.1 et DX.2 › tableaux d'interprétation (INR, digoxinémie, charge virale VIH) et 9.d deuxième intention, durée

Contexte : Le cours écrit que la cible du taux résiduel de ciclosporine ou tacrolimus et de la digoxinémie est « donnée non trouvée » ; INR cible 2,0–3,0 (2,0–3,5 valve mécanique) ; charge virale VIH sous inhibiteur de la protéase sans seuil.

Question : Quelles cibles thérapeutiques suisses ou européennes s'appliquent au taux résiduel de ciclosporine et de tacrolimus (selon l'organe et le délai post-greffe), à la digoxinémie (fourchette thérapeutique selon FI Digoxin Sandoz® ou équivalent suisse), à l'INR sous phenprocoumone selon l'indication (FA, TEV, valves) et au seuil de charge virale VIH définissant l'échec virologique (EACS 2024) ? Quelle conduite face à l'ajout ou à l'arrêt du millepertuis (délai de contrôle du taux). Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-035 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 › syndrome sérotoninergique (fenêtre « tachycardie », critères diagnostiques, algorithme étape 5)

Contexte : Le cours dit que les critères diagnostiques formels (Hunter) et le traitement spécifique du syndrome sérotoninergique ne figurent pas dans les sources consultées.

Question : Quels critères diagnostiques du syndrome sérotoninergique (Hunter, Sternbach) et quel traitement (arrêt, benzodiazépine, cyproheptadine : dose et disponibilité en Suisse, refroidissement) recommandent Tox Info Suisse ou la recommandation européenne la plus récente ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-037 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 › fenêtre « anticoagulants oraux directs (AOD) » et monographie plantes–AVK (critères, classement des plantes)

Contexte : Le cours cite l'interaction rivaroxaban–inducteurs (ASC −50 % avec rifampicine) et la revue de Tan et Lee ; aucun critère formel de l'interaction plante–AVK ; liste de plantes à risque

hémorragique tirée d'une revue.

Question : Selon les informations professionnelles suisses de Xarelto®, Eliquis®, Lixiana® et Pradaxa® (date de révision), quelle conduite tenir avec le millepertuis et les autres inducteurs puissants ? Quelles plantes et compléments une source suisse ou européenne récente (EMA/HMPC, Swissmedic) classe-t-elle à risque hémorragique avec les AVK et les AOD ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-039 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › examens (RUCAM, bilan hépatique) et pronostic ; Partie 2 › DX.3 › hépatotoxicité des plantes (fréquence, grades d'encéphalopathie, syndrome d'obstruction sinusoïdale, corticoïde, Tesalin® N, surveillance, guérison)

Contexte : Le cours retient RUCAM ≥ 9 hautement probable, ALAT ≥ 5 × LSN, MELD > 29 ; fréquence suisse de la HILI, définition des grades, signes du syndrome d'obstruction sinusoïdale, dose du corticoïde et calendrier de surveillance absents ; Tesalin® N : prudence en insuffisance hépatique.

Question : Quelle recommandation européenne la plus récente encadre l'hépatotoxicité médicamenteuse et végétale (EASL Clinical Practice Guidelines DILI 2019 ou mise à jour, CIOMS 2020) : seuils RUCAM, critères de gravité (loi de Hy, grades de West Haven), indication et dose des corticoïdes, calendrier de surveillance, critères de guérison ? Quels signes définissent le syndrome d'obstruction sinusoïdale (alcaloïdes pyrrolizidiniques) ? Que dit la FI suisse actuelle de Tesalin® N sur l'hépatotoxicité et la surveillance ? Existe-t-il un chiffre suisse de la HILI ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-040 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › tableau des examens (hypercalcémie par vitamine D) ; Partie 2 › DX.4 › tableaux d'interprétation (calciurie, calcium corrigé, créatinine, phosphate, PTH, $1,25(OH)_2D$, imagerie rénale), signes ECG, sténose aortique supravalvulaire, seuil LC-MS/MS

Contexte : Le cours cite 25(OH)D > 375 nmol/l, calcémie > 2,60 mmol/l, calciurie > 6,25 à > 7,5 mmol/24 h (FI Vi-De 3®) ; valeurs de référence suisses, signes ECG et imagerie absents.

Question : Quels seuils définissent l'intoxication à la vitamine D (25(OH)D, calcémie totale et ionisée, calciurie) selon une source suisse (OSAV, Commission fédérale de l'alimentation 2012/actualisation, FI Vi-De 3®) ou l'EFSA 2023 (limite supérieure d'apport) ? Quels signes ECG de l'hypercalcémie et quelle imagerie rénale (échographie, néphrocalcinose) retenir ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-042 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 › phytothérapie en grossesse et allaitement (fenêtres « gingembre », « livèche », 7.4 exposition du nourrisson allaité, signes cliniques, gold standard, surveillance)

Contexte : Le cours classe le gingembre « sûr » sans dose ni forme ; motif de la contre-indication de la livèche absent ; « autres plantes » pendant l'allaitement : appliquer la FI.

Question : Quelle dose et quelle forme de gingembre sont validées contre les nausées de la grossesse (FI suisse d'un produit autorisé, monographie HMPC/EMA, SSGO avis d'experts) ? Pourquoi la livèche est-elle contre-indiquée pendant la grossesse ? Quelles sources suisses ou européennes (Swiss Teratogen Information Service, LactMed équivalent européen, HMPC) classent les plantes compatibles ou non avec l'allaitement ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-043 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › hésitation vaccinale (fenêtres « questionnaire PACV », « anthroposophie », épidémiologie ROR, fenêtre légale CC art. 307, pronostic de la rougeole)

Contexte : Le cours dit que la couverture vaccinale suisse ROR est « non trouvée (rapport OFSP non téléchargeable) » ; le signalement à l'APEA et le secret médical en cas de refus vaccinal parental n'ont pas été lus.

Question : Quelle est la couverture vaccinale suisse ROR (1 et 2 doses à 2, 8 et 16 ans) selon le monitoring cantonal de l'OFSP le plus récent, et quelles données européennes (ECDC) relient hésitation vaccinale et médecines complémentaires ? Le refus parental d'un vaccin justifie-t-il un avis à l'APEA (CC 307, 314c) et dans quelles limites du secret médical (CP 321) ; que recommandent l'OFSP et Pédiatrie Suisse ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-047 — Haute — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › tableau des examens (saturnisme : plombémie, grossesse) et pronostic ; Partie 4 › DX.10 › intoxication par métaux lourds (critères, gold standard, alternatives, fenêtre « importation, déclaration », pronostic)

Contexte : Le cours cite la phase pilote SHeS 2020–2021 (médiane 13 µg/l, P95 37 µg/l), les symptômes vers 400–790 µg/l, l'édétate calcique préféré au succimer pendant la grossesse ; valeurs de référence suisses, critères formels, chélation chiffrée et avertissement Swissmedic sur l'ayurvéda absents.

Question : Quelles valeurs de référence et quels seuils d'action de la plombémie (adulte, femme enceinte, enfant) retiennent une source suisse (OFSP, Suva, Tox Info Suisse, programme suisse de biosurveillance) ou européenne récente (EFSA) ? Quelle chélation (succimer, édétate calcique disodique, DMPS : seuil d'indication, dose, disponibilité en Suisse) est recommandée ? Swissmedic a-t-il publié une mise en garde sur les préparations ayurvédiques ou asiatiques contaminées par le plomb ou le mercure (date, URL) ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-030 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › cadre déontologique et professionnel du médecin ; formations ISFM ; Partie 4 › DX.9 › fenêtre transversale « statut légal du chiropraticien »

Contexte : Le Code FMH (art. 8 « pratiques discutables », art. 10 « information ») est resté inaccessible ; seuls le programme ISFM de phytothérapie (SSPM, 2015) a été lu ; sigles ASA, ASMOA, SSMH, SMGP non développés ; remboursement de la chiropraxie et de l'ostéopathie non traité.

Question : Que disent les articles du Code de déontologie de la FMH (version en vigueur, URL) sur les méthodes complémentaires et l'information du patient ? Quels sont la signification et les programmes ISFM en vigueur des attestations de formation complémentaire en médecine complémentaire (ASA acupuncture-MTC, ASMOA médecine anthroposophique, SSMH homéopathie, phytothérapie SSPM, SMGP) ? Quel est le statut LPMéd du chiropraticien et quelle prise en charge AOS (OPAS art. 4b, OAMal) s'applique à la chiropraxie et à l'ostéopathie ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-031 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › fenêtre « Autorisation des médicaments : LPTh art. 14, 15, 2… » (OAMédcophy art. 31, liste SAT)

Contexte : Le cours cite l'autorisation sur déclaration (LPTh art. 15) et la liste SAT de l'annexe 10 de l'OAMédcophy, sigle non développé.

Question : Que signifie la liste « SAT » de l'annexe 10 de l'OAMédcophy (RS 812.212.24, état en vigueur) et quelles conditions d'autorisation simplifiée ou sur déclaration s'appliquent aux médicaments asiatiques, homéopathiques, anthroposophiques et phytothérapeutiques en Suisse ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-032 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › point 2 (épidémiologie, ESS 2017 vs 2022) ; Partie 1 › DX.2 épidémiologie ; Partie 2 › DX.4 et DX.5 (fréquence des intoxications vitaminiques, usage de plantes en grossesse en Suisse) ; Partie 3 › DX.7 (gui)

Contexte : Le cours cite l'ESS 2017 (24,7 % → 28,9 % d'usage de médecine complémentaire, 7,0 % de phytothérapie) ; chiffres ESS 2022, fréquence suisse des intoxications vitaminiques, part suisse de l'étude multinationale sur la grossesse et usage du gui en oncologie non trouvés.

Question : Quels chiffres de l'Enquête suisse sur la santé 2022 (OFS) décrivent le recours aux médecines complémentaires (global, par méthode, phytothérapie) et comment évoluent-ils par rapport à 2017 ? Quelle est la fréquence suisse des intoxications par vitamines (Tox Info Suisse, rapport annuel le plus récent), de l'usage de plantes pendant la grossesse (part suisse de l'étude multinationale de Kennedy 2013) et du recours au gui chez les patients cancéreux en Suisse ? Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-033 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 et DX.2 › point 2 (épidémiologie des interactions)

Contexte : Le cours dit que les sources ne chiffrent ni l'incidence suisse, ni l'âge, ni la mortalité des interactions millepertuis et plantes–AVK.

Question : Existe-t-il des données suisses (Swissmedic, pharmacovigilance, Tox Info Suisse, études hospitalières) ou européennes récentes sur la fréquence, l'âge et la mortalité des interactions médicamenteuses dues au millepertuis et des saignements liés aux plantes sous antagoniste de la vitamine K ? Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-036 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 › fenêtre « déclaration à Swissmedic (ElViS) » ; Partie 2 › DX.4 › fenêtre transversale 12.1 « Déclaration »

Contexte : Le cours cite LPTh art. 59 (état 1.1.2025) ; aucune recommandation suisse de prévention trouvée ; un complément alimentaire relève de l'OCAl, voie de déclaration incertaine.

Question : Comment déclare-t-on en Suisse un effet indésirable d'un médicament phytothérapeutique (ElViS, Swissmedic) et d'un complément alimentaire (OSAV, autorité cantonale, Tox Info Suisse) ; existe-t-il une recommandation suisse de prévention des interactions avec les plantes (Swissmedic, pharmaSuisse, SSPM) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-044 — Moyenne — LOT 243 · SSP O7.21

Emplacement : LOT_243_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › médecine alternative substitutive en oncologie (motifs du refus, critères, traitements conventionnels, Iscador®)

Contexte : Le cours dit qu'aucun critère formel n'existe pour la substitution, que les doses oncologiques relèvent de l'oncologie et que les Cochrane 2008/2019 sur le gui ne montrent pas de bénéfice de survie.

Question : Que recommandent la Ligue suisse contre le cancer, la SSOM (Société suisse d'oncologie médicale) ou l'ESMO (position la plus récente sur les médecines complémentaires, SIO-ASCO comme comparaison) face au patient qui refuse un traitement curatif au profit d'une méthode alternative ? Quelle est l'indication autorisée actuelle d'Iscador® selon la FI suisse et quelle place lui donne l'évidence la plus récente ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et

lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P21 — 20 questions : E-016, E-021, E-022, E-024, E-025, E-029, E-034, E-035, E-037, E-039, E-040, E-042, E-043, E-047, E-030, E-031, E-032, E-033, E-036, E-044